

体医养结合视域下传统体育养生功法 促进老年健康的价值、困境与路径

王地 高莹

浙江大学教育学院体育学系, 浙江 杭州 310058

摘要:传统体育养生功法凭借强度适中、文化认同高、适应性强等优势,为体育干预融入老年健康服务提供了可行路径。研究认为,传统养生功法在提升老年人生理功能、防控健康风险、优化资源配置与赋能健康管理等方面具有独特价值。但在实践中面临服务供给不足、跨部门协同不畅、科学证据薄弱、社会认知欠缺等困境。基于此提出,应从服务标准建设、现代传播体系、健康服务链条融入、科技赋能研究等方面协同推进,推动传统体育养生功法在体医养结合实践中常态化嵌入。

关键词:体医养结合;传统体育养生功法;老年健康;健康服务

中图分类号:G85 **文献标识码:**A **文章编号:**2096—1839(2026)04—0114—03

DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011655

随着我国人口老龄化程度持续加深,我国将进入重度老龄化阶段。这一结构性变化给我国经济社会发展与公共财政平衡带来多重压力,也使得慢性病负担与照护需求日益凸显。在此背景下,提升老年人身心健康水平成为一项紧迫的社会议题。

近年来,党中央、国务院在《关于加快发展养老服务业的若干意见》《“健康中国2030”规划纲要》等政策文件中,多次提出“医养结合”“体医结合”等概念,以期促进体育锻炼纳入疾病预防与康复体系。因此,学界围绕“体医养结合”展开了多方面研究,旨在整合体育、医疗、养老三类资源,为老年人提供覆盖全周期、体现差异化的健康促进服务^[1]。然而,当前的实践过程中体育干预仍难以有效融入养老服务与医疗康复的整体流程,部分环节存在“重疗护、轻运动”的倾向,运动干预多停留在活动组织与短期项目层面。因此,如何将运动干预转化为医疗与养老体系可承接的日常化实践,成为推动体医养融合的关键议题。中华传统体育养生功法植根于中医阴阳五行、经络脏腑等整体观,以治未病为核心目标,融合形体活动、呼吸调节与心理调节为一体,代表性项目包括了太极拳、健身气功八段锦等^[2]。该类功法强度适中、文化认同度高、适应场景广泛,为体育资源融入医养服务提供了适宜载体^[3]。基于此,本研究立足健康中国战略,系统性阐述传统体育养生功法在促进老年健康方面的多重价值,精准性识别其推广应用中的现实困境,并

探讨相应的实践路径。

1 体医养结合视域下传统体育养生功法促进老年健康的价值意蕴

1.1 促进老年人基础功能整体提升

传统体育养生功法通过低负荷且持续的日常练习,能够改善老年人的肌力、心肺耐力、关节活动度与平衡控制等基础功能,为身体机能的维持预防跌倒等健康风险提供重要基础,其动作节奏、强度和技术可根据个体情况进行分级与灵活调整,以适应不同体能及慢性病老年患者的参与需求,有利于提升运动参与的持续性。传统养生功法对场地和器械的依赖度低,适合居家练习,也便于在社区与养老机构以小组形式开展活动,有助于融入日常生活与照护流程,促进运动习惯的长期保持。总之,传统体育养生功法以中医整体观为指导,通过形体活动、呼吸吐纳与心理调节的协同作用,实现对老年人生理功能的多维度整合提升。

1.2 促进老年人健康风险整体防控

老年健康风险具有复杂性与系统性,常体现为慢性病、功能衰退与照护需求的多重叠加。传统体育养生功法强度可调、组织实施门槛低、场地适应性强,能够为不同环节的风险防控提供日常化运动干预支撑。一是在疾病预防方面,传统养生功法以包含中低强度有氧、力量维持与平衡训练等形式,便于老年人在家庭和社区开展规律练习,为防控代谢性相关疾病与跌倒风险奠定基础;二是在慢病管理方面,传统养生功

基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题,编号:24NDQN156YBM。

作者简介:1.王地(1993~),男,硕士,讲师。研究方向:民族传统体育学。

法可与基层医疗的随访、健康教育等服务结合,作为生活方式干预的重要组成部分,促进健康行为的持续养成;三是在康复与长期照护方面,传统养生功法可衔接医疗康复后的功能恢复,并在社区、家庭与养老机构中持续开展,推动运动干预从短期项目转变为医养服务体系中的常规内容,增强健康风险防控的连续性与可及性。

1.3 促进老年人服务资源整合利用

面向健康老龄化的现实需求,传统体育养生功法既有助于个体运动参与与功能维护,也在服务层面促进资源整合。一是传统养生功法推动体育公共服务由单纯健身拓展为兼具健康维护与风险防控功能的日常支持服务,使其更易融入社区与养老服务体系,并承担基础性健康支持职能;二是依托低成本、可持续的日常练习模式,传统养生功法有助于推动健康管理关口前移,延缓慢性病进展与功能衰退,从而减轻医疗服务压力、节约医疗支出;三是传统养生功法对硬件设施依赖小,便于在养老机构以小组形式开展,能够在不大幅增加投入的情况下丰富服务内容,提升机构在功能维护与健康促进方面的服务能力,推动养老服务从生活照料向健康支持延伸。

1.4 促进老年人健康管理整合赋能

推动老年人由被动接受照护向主动参与健康管理,是提升健康管理成效与可持续性的关键^[5]。作为重要的科学运动实现载体,传统体育养生功法承载着“治未病”“调养身心”的健康理念,有助于提升老年人的健康管理能力。一是传统养生功法强调顺应生理变化、注重日常调护,与现代健康管理中的预防为主、功能维护等理念高度契合,易于老年人理解与接受,有助于在练习中逐步形成主动健康意识;二是传统养生功法动作结构稳定、便于重复练习,老年人在练习中可逐渐掌握呼吸调节、姿势控制与身心放松等自我调节技能,实现健康知识向实操能力的转化;三是传统养生功法为老年人提供了稳定的日常锻炼载体,可与健康评估、运动指导、随访支持等服务衔接,促进健康服务从碎片化供给向连续性支持转变。

2 体医养结合视域下中华传统体育养生功法促进老年健康的现实困境

2.1 传统养生功法服务有效供给不足

目前传统体育养生功法在基层健康服务中的落地仍面临供给不足的问题。首先,社区层面的项目覆盖存在区域不均衡,部分地区存在公共服务盲区,与老年人就近参与的需求脱节,导致传统养生功法活动呈现为零散分布,难以形成稳定供给;其次,传统养生功法推广依赖现场指导,但基层专业指导人员数量有限、能力参差,部分站点存在“有场地无指导、有活动不规范”的现象;最后,近年来有关部门陆续推出导引养生功十二法、大舞、太极养生杖等新功法,但相关课程与教学标准体系尚不健全,技术规范与分级标准相对滞后,不利于规模化推广与质量控制。

2.2 跨部门协同机制不畅

体医养结合涉及体育、卫生健康、民政、医保等多部门协作,但在基层实践中协同机制仍不顺畅。一方面,体育部门侧重健身促进与活动组织,卫健部门聚焦疾病管理与公共卫生,两者在考核指标、资源配置与业务对接上尚未形成稳定的协作机制;另一方面,体育部门多以活动形式开展,与基层健康评估、风险分层、慢病随访及照护管理之间缺乏有效衔接,导致运动干预难以与健康档案、随访记录整合,服务供给与健康管理相对分离;此外,尽管政策鼓励医保支持医养结合,但在筹资渠道、支付激励与持续运营保障方面仍需进一步完善。

2.3 传统养生功法科学证据支撑薄弱

传统体育养生功法的健康效应虽有一定研究积累,但尚不足以形成标准化、可复制的证据体系。从研究规模看,太极拳相关研究较为丰富,累计包含500余项临床试验与120余篇系统综述;而八段锦、五禽戏等功法的研究数量相对有限,八段锦相关文献仅517篇,五禽戏的系统综述在特定主题检索中仅纳入8项研究,且高质量循证研究明显不足;在运动处方方面,传统体育养生功法练习的频率、时长、强度等核心参数缺乏统一标准,不同研究与应用场景下的强度分级、进阶规则与安全边界差异较大,制约了处方的推广与应用;此外,现有研究在评价工具、测量维度与时间节点上缺乏一致性,难以整合证据并建立跨场景的质量控制与效果评估标准。

2.4 社会认知与文化融合欠缺

传统体育养生功法融入体医养实践仍受社会认知与健康文化的制约。具体来看,目前大众易将传统养生功法理解为普通的舒展活动,对其技术要领、练习层次及健身机理认识不足,参与行为易呈现随意性与间歇性;同时,医疗体系功法的认知与应用仍显滞后。多数基层医护人员对功法的健康效应缺乏系统培训,在临床实践中较少将其纳入慢病管理或康复方案,更倾向于推荐西医标准化治疗手段,导致传统养生功法与医疗服务的衔接存在“最后一公里”障碍;此外,当前主流健康观念仍以疾病治疗与照护为主,运动干预在公众行为选择处于次要地位,体医养融合赖以形成的社会共识与文化基础仍显不足,亟须进一步夯实。

3 体医养结合视域下中华传统体育养生功法促进老年健康的推进路径

3.1 强化传统养生功法服务标准体系建设

推动传统养生功法稳定融入体医养服务体系,需建立统一的内容标准与质量控制依据。一是编撰标准化教学方案,明确动作要领、错误纠正、分级进阶等内容与课时结构,并针对老年群体制定安全提示与适配指南;二是发展个性化运动处方,基于健康筛查与功能评估,明确练习频率、强度、时间、方式与进阶规则,提升处方的可操作性与适应性;三是建立规范化评估机制,围绕技术准确性、安全性、分级合理性

等内容开展定期评价,并将评估结果反馈至课程修订与师资培训中,推动标准体系持续优化。

3.2 推动传统养生功法现代传播体系构建

构建涵盖人才培养、服务网络与传播渠道的现代传播体系,是扩大功法覆盖、保障服务质量的关键。一是培养复合型指导人才,使其不仅掌握传统养生功法技术,还具备健康筛查、风险识别与适老化沟通能力,并能开展分层指导与转介衔接;二是建设社区示范网络。依托社区党群服务中心、社区卫生服务机构、养老服务设施与公共健身场所,形成层级清晰、功能互补的服务节点,推动传统养生功法与公共服务资源对接;三是利用新媒体拓展传播渠道,围绕动作要领、常见错误、安全提示与分级进阶制作系统化的线上教学内容,并结合线下示范点开展指导和评估,实现“线上学、线下练、过程管”的融合传播模式。

3.3 深化传统养生功法融入健康服务链条

推动功法从健身活动转化为贯穿预防、干预、康复与随访的健康管理手段,需加强其在家庭、社区、机构与医疗体系中的衔接。一是完善家庭与社区协同的服务体系。依托居家养老服务网络建设,为居家老年人提供传统养生功法练习的场地、组织与社群支持,并通过家庭医生签约服务将传统养生功法嵌入日常健康管理,借助健康知识库、非药物处方等制度安排,为居家练习提供规范化指导;二是将传统养生功法纳入养老机构的日常服务流程。将功法从兴趣活动升级为机构康复与健康促进的常态化内容,在开展前进行功能评估与风险分层,在实施中加强过程看护与异常监测,并将动作选择、练习频次与进阶安排纳入机构的日程管理与记录体系,使传统养生功法与晨练、康复训练、慢病管理等环节形成有机衔接;三是促进传统养生功法与医疗康复体系的有效衔接。依托医联体、医共体等协同机制,将医院的康复评定与运动指导向基层延伸,在基层慢病管理与连续服务框架内建立转介与随访机制,推动传统养生功法

在出院后延续康复与长期健康管理中发挥作用,提升干预的安全性与针对性。

3.4 加强传统养生功法科技赋能与应用研究

通过科学研究与技术应用提升传统养生功法的社会认同与专业可信度,是推动其广泛融入健康服务的重要支撑。一是开展循证研究。围绕肌力、平衡、跌倒风险与慢病指标等核心指标,通过随机对照试验、系统评价与真实世界研究等方法,积累高质量证据,支持专业判断与政策采纳;二是开发智慧学练辅助工具,以适老化设计为导向,在动作要点提示、常见错误纠正、负荷与强度提示、进阶指导与风险预警等方面提供智能支持,通过陪伴式数字化服务提升练习的可及性、规范性与安全性,提升老年人的学习体验与持续参与意愿;三是搭建数据共享信息平台,在安全合规前提下推动传统养生功法服务与体质监测、慢病管理、康复随访等数据互通共享,构建覆盖评估、处方、执行与效果反馈的完整数据链条,为传统养生功法干预的长期效果与人群适配提供持续证据积累,提升传统养生功法服务的公共可信度与社会认可度。

参考文献:

- [1] 王会儒,姚忆.“传统养生体育+医疗+养老”的老年健康干预模式构建[J].中国体育科技,2017(3):8-13.
- [2] 司红玉.从导引术、气功到健身气功之现象学研究[J].上海体育学院学报,2011(1):92-94.
- [3] 范铜钢,虞定海.传统体育养生功法技术活化的历史、现状与未来[J].上海体育学院学报,2019(6):96-103.
- [4] 韩梦姣.传统导引养生功法习练与老年人生存质量关系的实证研究[J].武术研究,2023(9):98-102.
- [5] 杨宗友,隆承宏,曹雷,等.社区体医养结合的老年智慧健康服务新模式:生成逻辑、运行要素与发展路径[J].北京体育大学学报,2025(10):55-65.

(责任编辑:郭维维)

Traditional Sports Health-cultivation Techniques in Promoting Elderly Health from the Perspective of Sports-Medical-Nursing Integration: Value, Challenges and Pathways

Wang Di Gao Ying

(Department of Sports Science, Zhejiang University, Hangzhou Zhejiang 310058, China)

Abstract: Traditional sports health-cultivation techniques, with advantages of moderate intensity, high cultural acceptance and strong adaptability, provide a feasible pathway for integrating sport intervention into elderly health services. The research suggests that these techniques have unique value in enhancing physiological functions, preventing and controlling health risks, optimizing resource allocation, and empowering health management among the elderly. However, in practice, they face challenges such as insufficient service supply, poor inter-departmental coordination, weak scientific evidence, and lack of social awareness. Based on this, it is proposed that collaborative efforts should be made in service standard construction, modern dissemination systems, service chain integration, and technology-empowered research to promote the normalized embedding of traditional sports health-cultivation techniques into sports-medical-nursing integration practice.

Keywords: Sports-medical-nursing integration; Traditional sports health-cultivation techniques; Elderly health; Health service